

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

УДК:616-036.-65

Е.И.Ишкинин, А.Ж.Жылкайдарова, .С.Нургалиев

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Изменение эпидемиологической картины рака предстательной железы в Казахстане за период 2004-2013 годы

Аннотация: Анализ эпидемиологии рака предстательной железы в отдельных странах мира, заболеваемости, смертности и их соотношения. Для населения Казахстана за 2004 – 2013 годы показатели: динамика интенсивных и стандартизованных показателей заболеваемости, смертности, возрастные показатели заболеваемости, по возрастные стандартизованные показатели смертности. Территориальные уровни заболеваемости в разрезе областей и город/село. Информация о распределении впервые выявленных пациентов по стадиям. Динамика находящихся под наблюдением, 5 летней выживаемости и одногодичной летальности пациентов.

Ключевые слова: рак предстательной железы, эпидемиология, стандартизованные показатели заболеваемости.

Актуальность. Согласно базе данных GLOBOCAN [1] в 2012 году, у 1,1 миллиона мужчин впервые выявлено злокачественное новообразование предстательной железы, умерло 307 000 больных. Среднемировая заболеваемость составила 31,1‰, 2 место в структуре онкозаболеваемости (13,6%), смертность 7,8‰, 2 место в структуре онкосмертности (6,6%). Среднемировой показатель отношения смертности к заболеваемости составляет 25,1%. Уровни заболеваемости (на 100 000 жителей, приведенных по возрастной структуре к мировому стандарту World) по странам (таблица 1) колеблются от 2,0‰ в Узбекистане и 5,3‰ в Китае, до 127,3‰ во Франции, 119,0‰ в Швеции и 115,2‰ в Австралии. Однако в этих странах «отношение смертности к заболеваемости» одно из самых низких в мире. Показатель «отношение смертности к заболеваемости», характери-

зующий уровень развития онкологической помощи в той или иной стране составляет 25,1%. Данный показатель является высоким в развивающихся странах, что свидетельствует о серьезности проблемы радикального лечения злокачественных новообразований предстательной железы и необходимости их раннего выявления. Низкие показатели отношения смертности к заболеваемости отмечаются преимущественно в развитых странах мира: во Франции 7,9%, в США – 10%, в Канаде 10,6%, в Австралии 11,2%, в Швеции 15,0%. В Узбекистане, несмотря на невысокий уровень смертности 1,5‰, этот показатель равен 75%, что говорит об имеющихся проблемах в ранней диагностике и лечении. Важно отметить, что по сведениям GLOBOCAN 2012 отношение указанных показателей для Казахстана выглядит значительно хуже (57,7%), чем по уточненным сведениям канцер-регистра (43,6% при расчете интенсивных (грубых) показателей и 43,7 при расчете стандартизованных показателей).

Эти различия служат подтверждением определенного прогресса в ранней диагностике и лечении этой локализации в нашей стране. Казахстан входит в группу стран с низким уровнем заболеваемости, при этом в последние годы в связи с началом скрининга рака предстательной тенденция к увеличению впервые выявленных случаев с ранними стадиями, что приводит к своевременному и более радикальному лечению и снижению смертности. Оценочные показатели ВОЗ, GLOBOCAN 2012 несколько превышают реальные показатели Электронного регистра онкологических больных Республики Казахстан, что свидетельствует о более быстром улучшении ситуации, чем ожидалось по прогнозу. С 2013 года, осуществляется внедрение скрининга РПЖ в РК [3].

Таблица 1 - Заболеваемость злокачественными новообразованиями предстательной железы и смертность от них в отдельных странах мира в 2012 году (на 100 000 мужского населения, мировой стандарт, данные GLOBOCAN 2012)

Страна	Заболеваемость	Смертность	Отношение смертности к заболеваемости, %
Казахстан*	14,9	8,6	57,7
Казахстан**	11,7	5,1	43,6
Казахстан***	16,7	7,3	43,7
Кыргызстан	7,3	4,8	65,8
Российская Федерация	30,1	12,4	41,2
Узбекистан	2,0	1,5	75,0
Украина	20,3	10	49,3
Великобритания	73,2	13,1	17,9

Германия	77,3	10,4	13,5
Дания	91,3	19,5	21,4
Латвия	82,7	18,0	21,8
Литва	60,9	21,4	35,1
Нидерланды	83,4	13,5	16,2
Польша	35,9	12,2	34,0
Словакия	50,0	13,1	26,2
Украина	20,3	10,0	49,3
Финляндия	96,6	12,0	12,4
Франция	127,3	10,0	7,9
Швейцария	107,2	12,2	11,4
Швеция	119,0	17,8	15,0
Эстония	94,4	19,3	20,4
Китай	5,3	2,5	47,2
Корея	30,3	4,6	15,2
Япония	30,4	5,0	16,4
Австралия	115,2	12,9	11,2
Бразилия	76,2	16,6	21,8
Канада	88,9	9,4	10,6
США	98,2	9,8	10,0
все страны мира по данным GLOBOCAN 2012	31,1	7,8	25,1
Примечание: по данным ВОЗ, GLOBOCAN 2012			
** по данным ЭРОБ РК, интенсивные (грубые) показатели			
*** по данным ЭРОБ РК, стандартизованные показатели			

Несмотря на различия интенсивных и стандартизованных показателей отмечаются идентичные закономерности показателей заболеваемости (рисунок 1), $R^2 = 0,716$ и $0,723$ для интенсивных и стандартизованных показателей соответственно. Разница коэффициентов регрессии равна $0,007$. Также отмечаются идентичные

показатели смертности (рисунок 2), $R^2 = 0,097$ и $0,0298$ для интенсивных и стандартизованных показателей соответственно. Разница коэффициентов регрессии также равна $0,007$. Это говорит об отсутствии влияния на рост заболеваемости постарения населения.

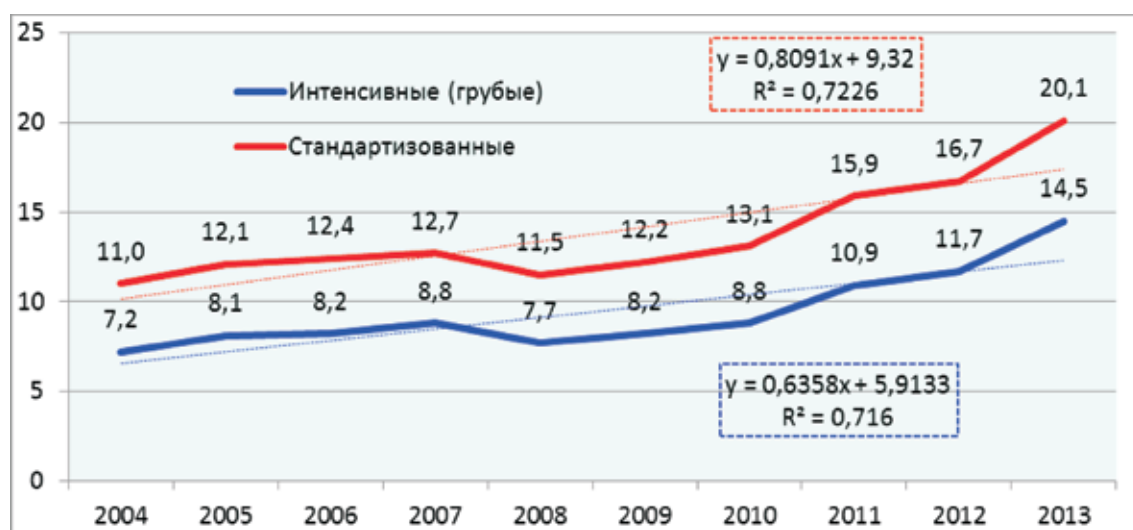


Рисунок 1 - Динамика показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями предстательной железы, на 100 000 мужского населения Республики Казахстан за 2004-2013 годы

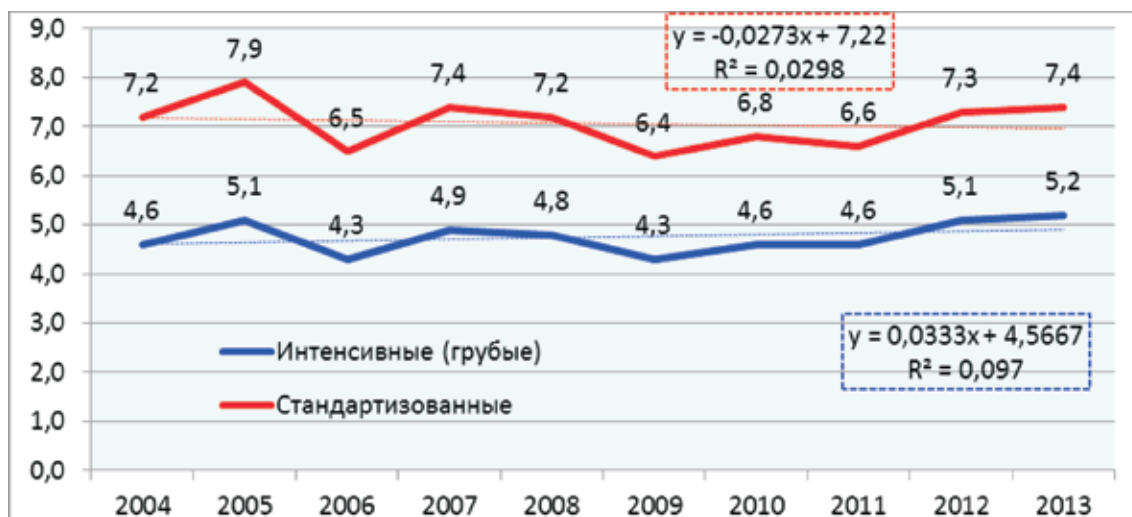


Рисунок 2 - Динамика показателей смертности от злокачественных новообразований предстательной железы, на 100 000 мужского населения Республики Казахстан за 2004-2013 годы

Анализ возрастного распределения интенсивных показателей заболеваемости рака предстательной железы показывает единичные случаи до 40 лет, увеличение данного показателя с 45-49 лет, с неуклонным ростом и максимальными показателями в возрасте 70 лет и старше. При этом в годы проведения скрининга (2012 и 2013)

отмечается нарастание этих показателей для возрастов целевых групп скрининга (рисунок 3).

Отмечается увеличение заболеваемости на 3,8‰ в среднем с 8,0‰ за 2004-2008 гг до 11,8‰ за 2009-2014 гг.

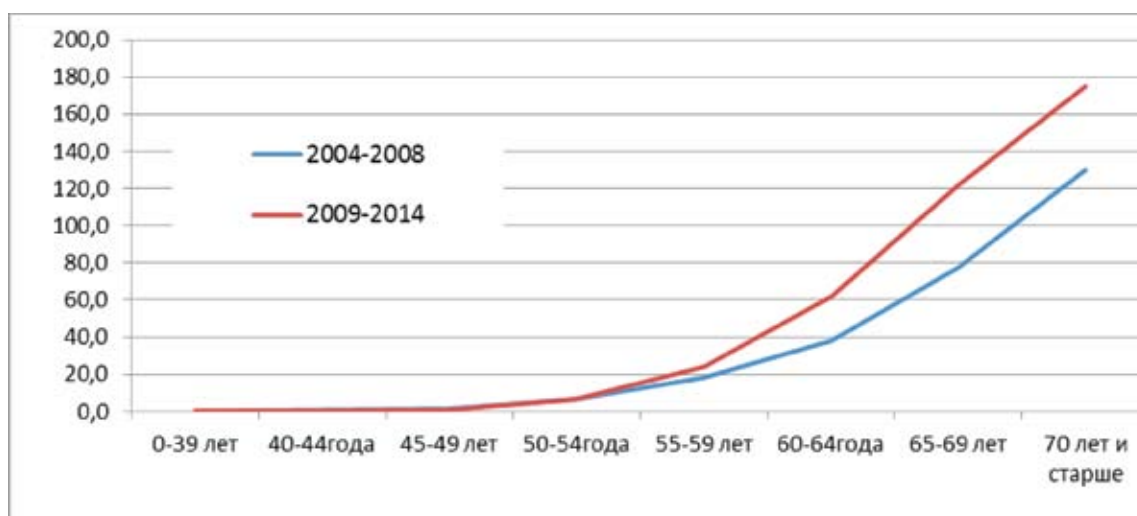


Рисунок 3 - Возрастные показатели заболеваемости злокачественными новообразованиями предстательной железы населения Республики Казахстан (средние показатели на 100 000 женского населения соответствующего возраста за 2004-2008 и 2009-2014 годы)

Анализ возрастного распределения стандартизованных показателей заболеваемости РПЖ (рисунок 4) показывает единичные случаи РПЖ до 40 лет, увеличение данного показателя с 45-49 лет, с неуклонным ростом и максимальными показателями в возрасте 70 лет и старше. При этом в годы проведения скрининга (2012 и 2013гг) отмечается нарастание этих показателей для возрастов целевых групп скрининга.

При анализе стандартизованных показателей от-

мечается увеличение заболеваемости на 3,7‰ в двух соседних пятилетках в среднем с 11,9‰ за 2004-2008 годы до 15,6‰ за 2009-2013 гг.

Анализ возрастного распределения смертности РПЖ с нарастанием возраста увеличиваются случаи смерти в возрасте 70 лет и старше (таблица 2). При этом в годы проведения скрининга (2012 и 2013 годы) отмечается уменьшение этих показателей для возрастов целевых групп скрининга.

Таблица 2 - Повозрастные стандартизованные показатели смертности ЗН предстательной железы мужчин РК (средние показатели на 100 000 мужского населения соответствующего возраста 2004- 2013 годы)

Возраст, лет	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	средние
0-39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40-44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45-49	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
50-54	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
55-59	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4
60-64	0,7	1,1	0,8	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	0,8	0,8
65-69	0,9	1,2	1,2	1,3	1,3	1,1	1,3	1,1	1,3	1,3	1,2
70 +	5,0	4,8	3,9	4,7	4,5	4,2	4,2	4,2	4,4	4,8	4,5
итого	7,2	7,9	6,5	7,4	7,2	6,4	6,8	6,6	7,3	7,4	7,1

При оценке в разрезе регионов отмечается увеличение стандартизованных показателей заболеваемости в регионах проведения скрининга.

Анализ двух пятилетних периодов (рисунок 4) показал увеличение стандартизованных показателей заболеваемости в городах Астана и Алматы, Акмолинской, Актюбинской, ВКО, Алматинской, Костанайской, Павло-

дарской областях. В городах Астана и Алматы ВКО, ЗКО. Карагандинской, Костанайской, Павлодарской областях показатели были выше среднереспубликанских показателей, а самые низкие показатели в южных и западных регионах Казахстана: в Южно-Казахстанской, Жамбылской и Кызылординской, Актюбинской, Атырауской, Мангистауской областях.

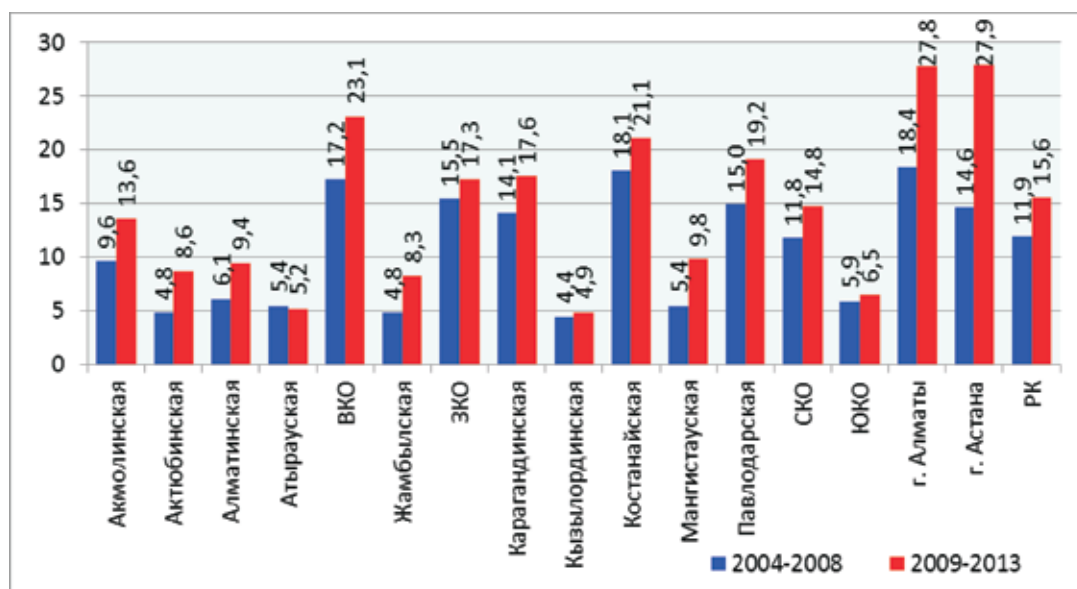


Рисунок 4 - Территориальные уровни заболеваемости населения Республики Казахстан злокачественными новообразованиями предстательной железы (стандартизованные показатели WHO World на 100 000 мужского населения, за 2004-2013 годы)

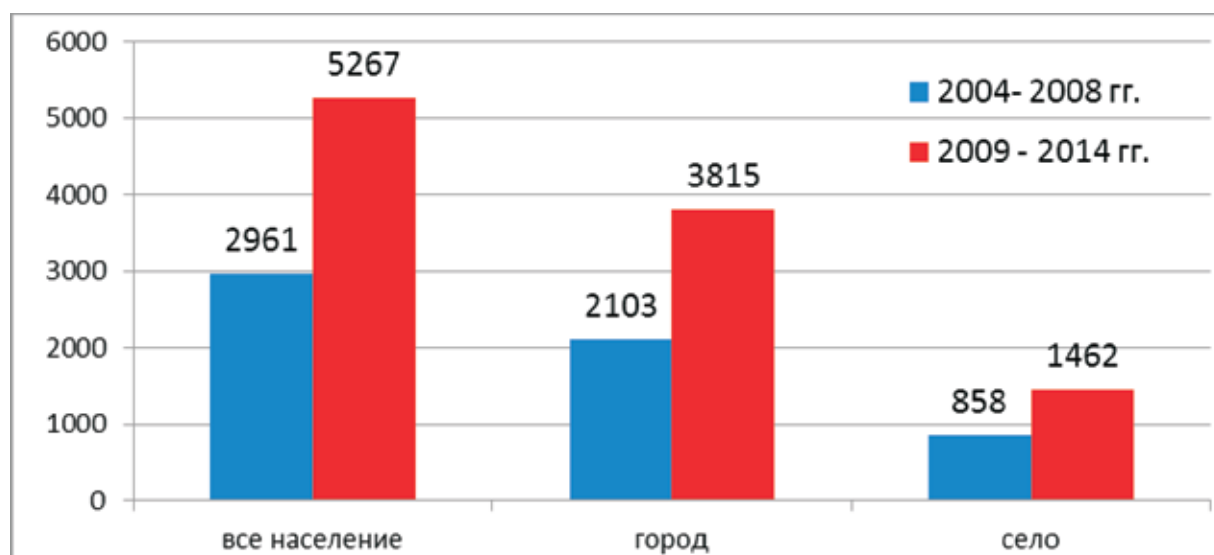


Рисунок 5 – Число впервые выявленных больных злокачественными новообразованиями предстательной железы за 2004-2014 годы

При оценке динамики интенсивных показателей заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований предстательной железы за период 2004-2013

годы у мужчин Республики Казахстан (рисунок 6), отмечается уменьшение отношения смертности к заболеваемости в 1,8 раз (с 63,9% 2004 года до 35,9% в 2013 году).



Рисунок 6 - Злокачественные новообразования предстательной железы: заболеваемость, смертность (грубые интенсивные показатели), отношение показателей смертности к заболеваемости (%) за 2004-2013 годы

При анализе впервые выявленных случаев по стадиям (рисунок 7), выясняется, что отмечается высокая запущенность при впервые установленном диагнозе с тенденцией к улучшению ранней диагностики на I- II стадиях, если в 2001г в III-IV стадии выявилось 76,1% больных РПЖ, то в 2014 году 46,3%. Из этого становится совершенно очевидным факт, что заболеваемость злокачественное новообразование предстательной железы

в нашей стране была намного выше за счет не выявленного локализованного рака. Можно отметить, что доля пациентов с I-II стадией в 2014 году увеличилась на 2,7% по сравнению с 2013 годом. Однако выявляемость злокачественных новообразований предстательной железы осталась на прежнем уровне, что говорит о необходимости повышении результатов диагностики рака предстательной железы.

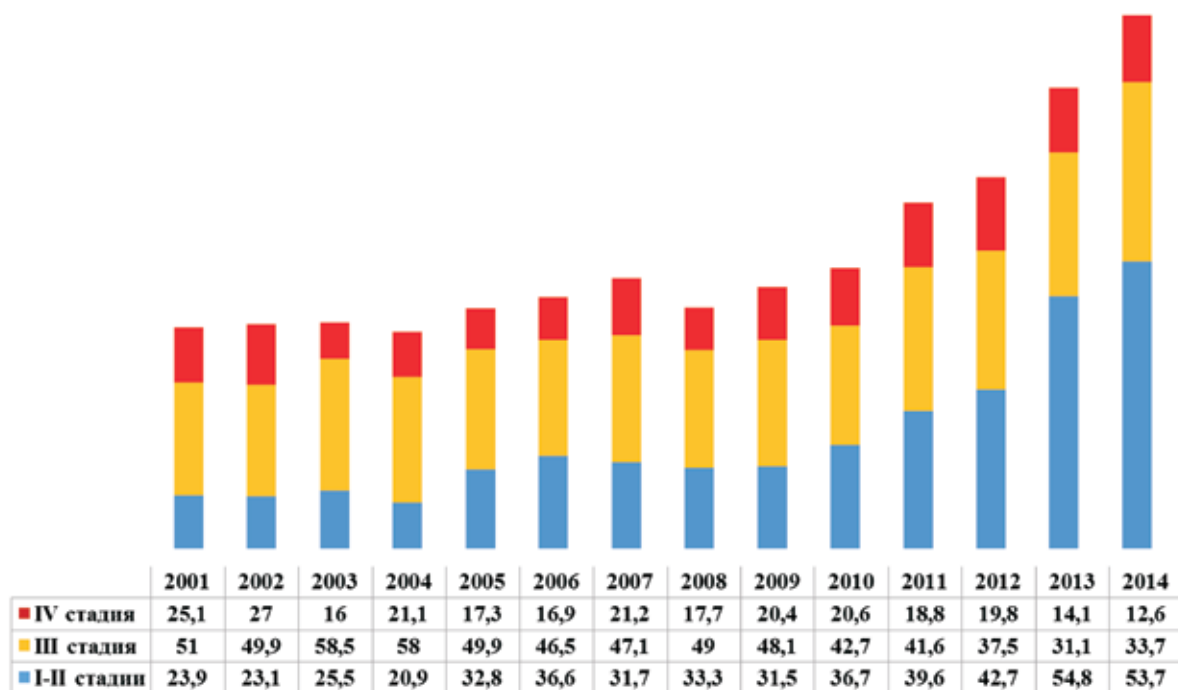


Рисунок 7 - Распределение по стадиям впервые выявленных больных ЗН предстательной железы Республики Казахстан за 2004-2014 годы



Рисунок 8 – Динамика больных ЗН предстательной железы находящихся под наблюдением в Республике Казахстан за 2004-2013 годы)

При этом на протяжении последних 10 лет наблюдения (рисунок 8) выросло число пациентов состоящих на

учете с этим диагнозом более 2-х раз в абсолютном и относительном выражении.



Рисунок 9 - Динамика 5 летней выживаемости и одногодичной летальности пациентов РПЖ, %

Несмотря на то, что доля пациентов, живущих 5 и более лет возросла (темп прироста – 9%), а доля пациентов умирающих в первый год установления диагноза (одногодичная летальность) уменьшилось (темп убыли 27,2%). При злокачественном новообразовании предстательной железы по прежнему самый низкий показатель 5 летней

выживаемости среди всех злокачественных новообразований.

Выводы. С 2004 года по 2013 год произошло кардинальное изменение эпидемиологической картины РПЖ в Казахстане (таблица 3).

Таблица 3 - Основные статистические показатели

Показатель	2004 год	2013 год	темп изменения, %
Интенсивные (грубые) показатели, простата на 100 000 мужчин	14,9	8,6	57,7
Заболеваемость	7,2	14,5	101,4
Смертность	4,6	5,2	13,0
отношение смертности к заболеваемости в %	63,9	35,9	-43,8
Стандартизованные показатели, простата на 100 000 мужчин	30,1	12,4	41,2
Заболеваемость	11,0	20,1	82,7
Смертность	7,2	7,4	2,8
отношение смертности к заболеваемости в %	65,5	36,8	-43,8
впервые установлен диагноз, абс.	523	1111	112,4
I-II стадии	20,9	54,8	162,2
III стадия	58,0	31,1	-46,4
IV стадия	21,1	14,1	-33,2
5 летняя выживаемость пациентов, %	23,4	25,5	9,0
одногодичная летальность, %	23,2	16,9	-27,2
контингент пациентов, абс.	1495	3254	117,7
контингент пациентов, на 100 000 населения	9,9	25,5	157,6

Список литературы

1. *Globocan 2012: Estimated Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide in 2012 / The International Agency for Research on Cancer, Lyons, France // <http://globocan.iarc.fr/Default.aspx>.*

2. Нургазиев К.Ш., Сейтказина Г.Ж., Байпеусов Д.М. и соавт. Показатели онкологической службы РК за 2001-2013 гг. (статистические материалы). - Алматы, 2002-2014 гг.

3. Нурғалиев Н.С., Жылкайдарова А.Ж., Ишкинин Е.И. Руководство по проведению скрининга целевых групп мужского населения на раннее выявление рака предстательной железы и обеспечению его качества / Под редакцией д.м.н. Нургазиева К.Ш. — Алматы, 2013. - 71 с.

Тұжырым

Е.И.Ишкинин, А.Ж.Жылкайдарова, Н.С.Нурғалиев
Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу
институты

**Қазақстандағы 2004 – 2013 жылдар аралығындағы
қуық асты безі қатерлі ісігінің эпидемиялық
көріністерінің өзгерістері**

Бөлек елдердегі қуық асты безі қатерлі ісігінің эпидемиологиясының анализі, аурушандығының, өлім көрсеткіштерінің және өзара салыстырмалылығы. Қазақстан халқының 2004 – 2013 жылдар аралығындағы көрсеткіштері: аурушандықтың қарқынды және стандартизацияланған динамикасы, өлім-жітімі, аурушандықтың жас бойынша көрсеткіштері, жас бойынша өлім-жітімінің стандартизацияланған көрсеткіштері. Облыс және қала/ауыл кесіндісіндегі аурушандықтың аймақтық деңгейлері. Саты бойынша алғаш анықталған науқастарды бөлуі жөніндегі ақпарат. Бақылауда болғандардың динамикасы, 5-жылдық өмір жітімі және науқастардың 1-жылдық өлім-жітімі.

Түйінді сөздер: қуық асты безінің қатерлі ісігі, эпидемиология, аурудың стандартизацияланған көрсеткіштері.

Summary

E.I.Ishkinin, A.Zh.Zhylkaidarova, N.S.Nurgaliyev
Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology

**Shift in epidemiology of prostate cancer in Kazakhstan
2004- 2013 years**

Prostate cancer epidemiology analysis in some countries, incidence, mortality, and their relations. For the population of Kazakhstan for 2004 - 2013 years indicators: the dynamics of intensive and standardized incidence, mortality, age-incidence rate, age-specific standardized mortality rates. Local incidence rates by regions and urban / rural population. Information about distribution of newly diagnosed patients by stages. Trends patients under observation, 5 year survival rate and one-year mortality of patients.

Key words: prostate cancer, epidemiology, age-standardized incidence.